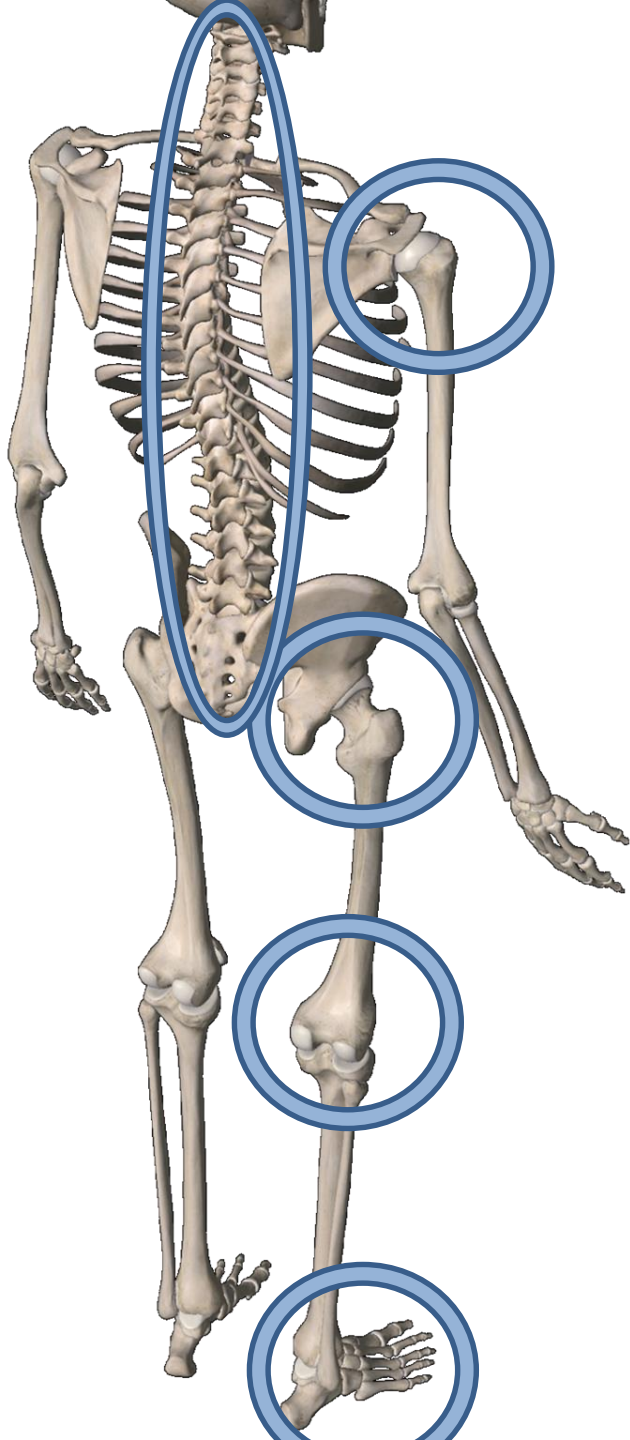




HCT loco examen clinique

- cette présentation sert **d'aide-mémoire** pour la préparation du cours bloc appareil locomoteur
- il s'agit d'un **résumé** et **non d'un support de cours de référence** pour la préparation des examens ECOS
- posez des questions pour clarifier les points peu clairs...

références

- <http://www.maitrise-orthopedique.com/articles/examen-clinique-de-lepaule-dans-la-pathologie-de-la-coiffe-des-rotateurs-80>
- <http://www.maitrise-orthopedique.com/articles/examen-du-genou-260>
- <http://www.maitrise-orthopedique.com/articles/examen-clinique-du-coude-300>
- manuel pratique de chirurgie orthopédique, B.Jolles-Haeberli, Elsevier Masson 2014

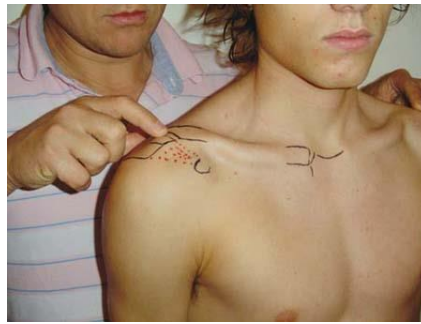
voir aussi moodle2.unil.ch

[Virtual Skills Lab --- Appareil locomoteur \(niveau 1 et 2\)](#)

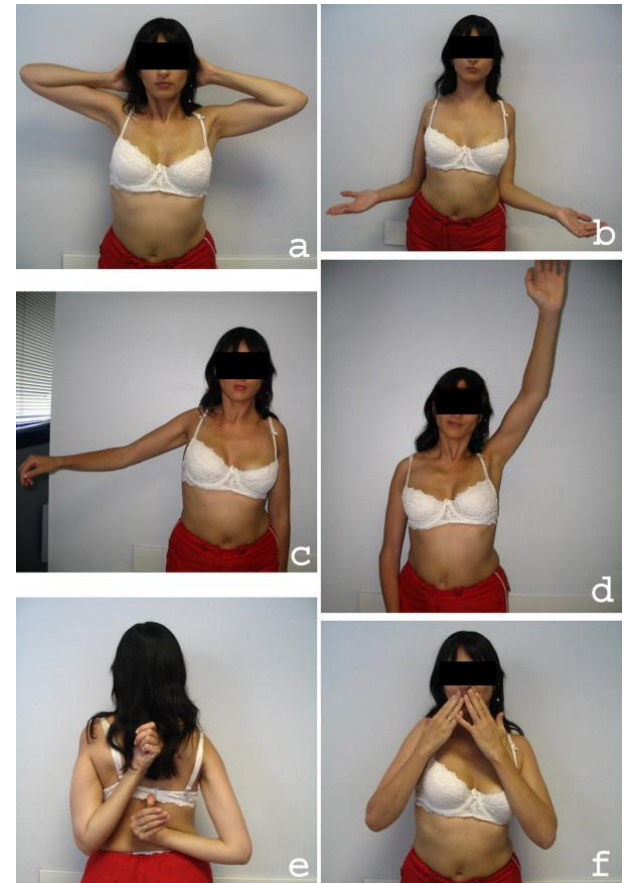
TOUTES les articulations

- TOUJOURS **bilatéral** et comparatif !!!

1. Inspection
2. Palpation



3. Amplitudes articulaires
4. Testing spécifique
5. **Neuro et vasculaire**



Examen clinique de l'épaule

Dr Vaclair

Inspection

(comparaison 2 côtés)

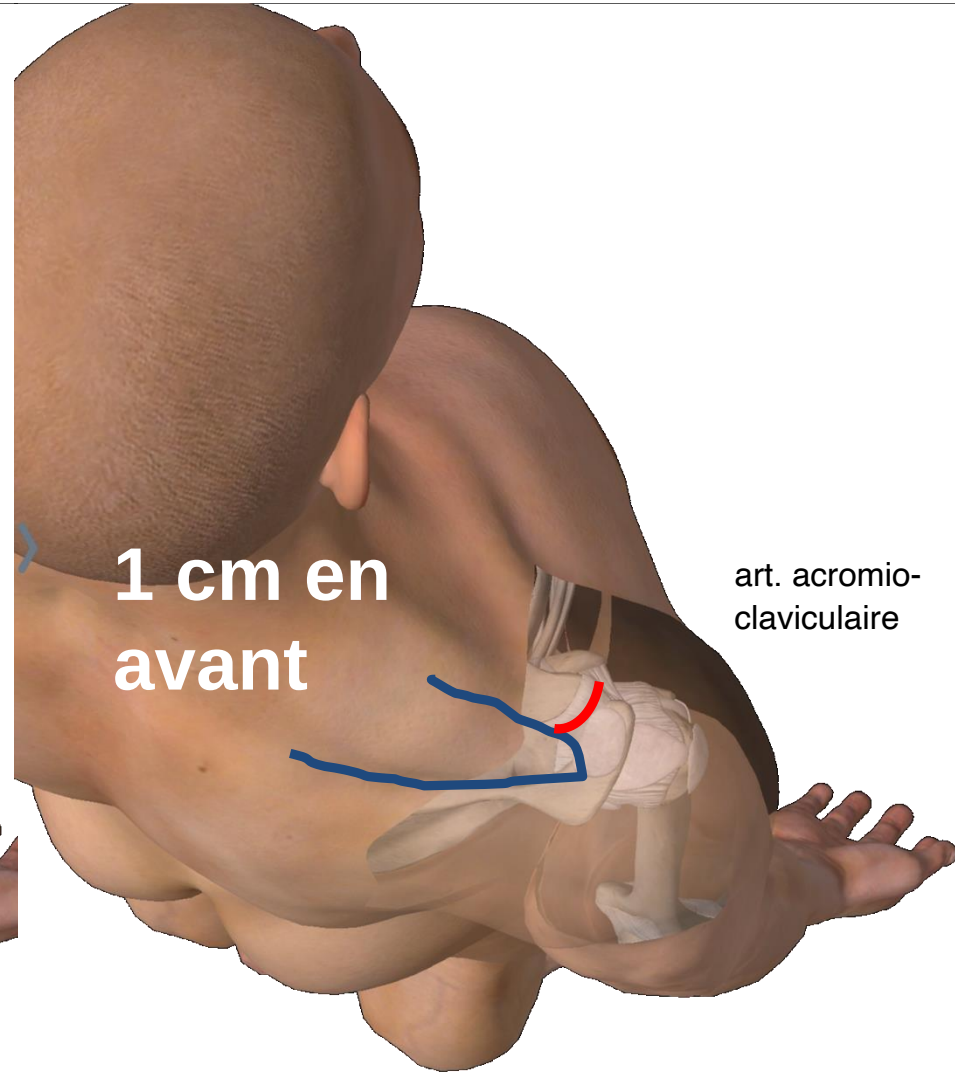
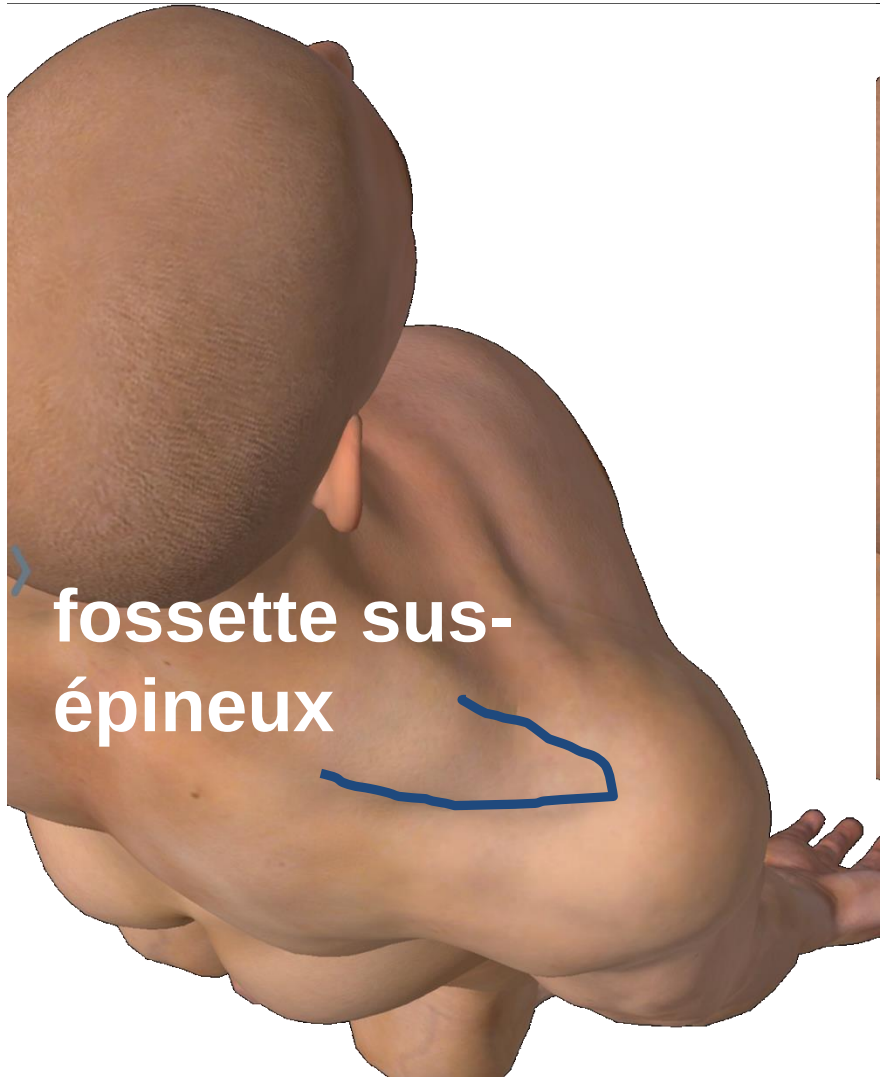
- Hématomes
- Tuméfactions
- Atrophie



Amyotrophie fosse sous-épineuse

- *Rupture sous-épineux*
- *Lésion nerf suprascapulaire*

palpation AC - Douleur



Toujours tester l'innervation de n. axial:
Sensibilité du moignon de l'épaule et la motricité (coude contre R)

Capsulite rétractive—> épaule gelée Mobilisation active: Rot ext + int (hauteur de la main sur la colonne)
Mobilisation passive si limitation en active

Long chef du biceps

- Douleur à la palpation

Recherche
tendinopathie:

- **Palm-up** test contre R: Douleur tendon



Après la mobilisation: tester tous les mm de la coiffe des rotateurs

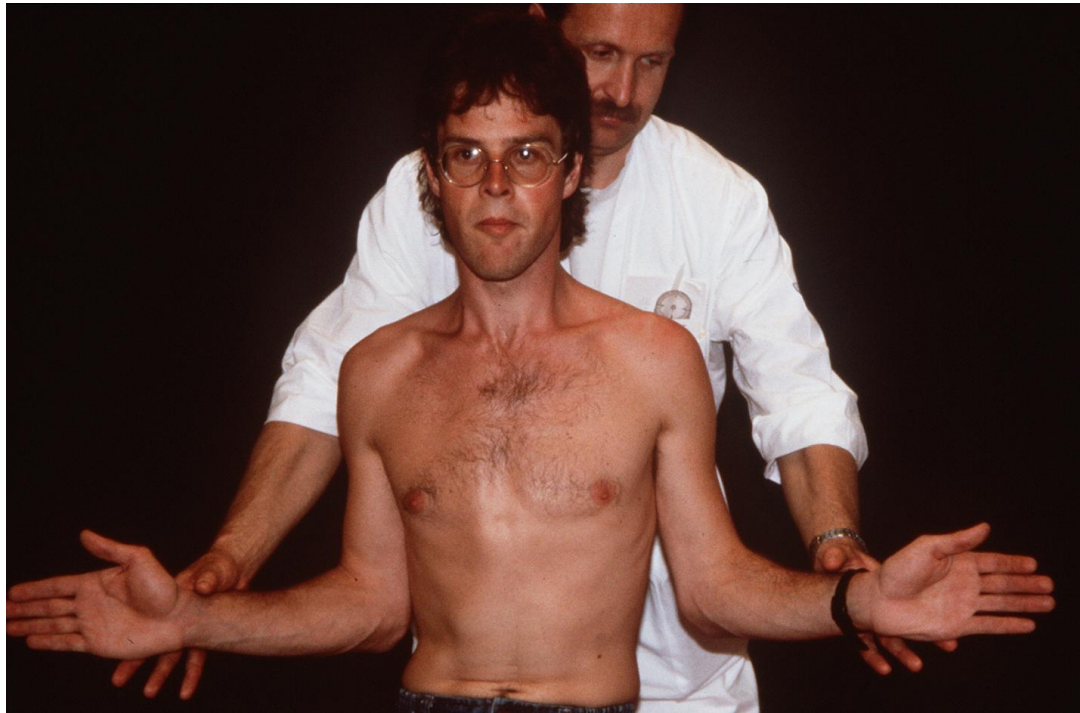
Sus-épineux (*supraspinatus*)

- Test de **JOBE** (FORCE) Positif si n'arrive pas à contrer la résistance



Sous-épineux (*infraspinatus*)

- RE contre résistance, coude au corps



Sous-épineux (*infraspinatus*)

- Signe du **portillon** (*rappel automatique ou external rotation lag sign*)



Petit Rond (*Teres Minor*)

- Manœuvre de **Patte** : abduction 90°, RE contre résistance



Sous-scapulaire (*subscapularis*)

- Lift-off test de Gerber



Normalement, le patient peut écartier la main du plan du dos ; en cas de rupture, la main reste «collée» aux lombes. Test Positif si il existe une déficience

Sous-scapulaire (*subscapularis*)

- **Belly Press** (si patient ne parvient pas à mettre la main dans le dos)



Conflit sous-acromial

- Signe de Hawkins



Examen clinique du rachis

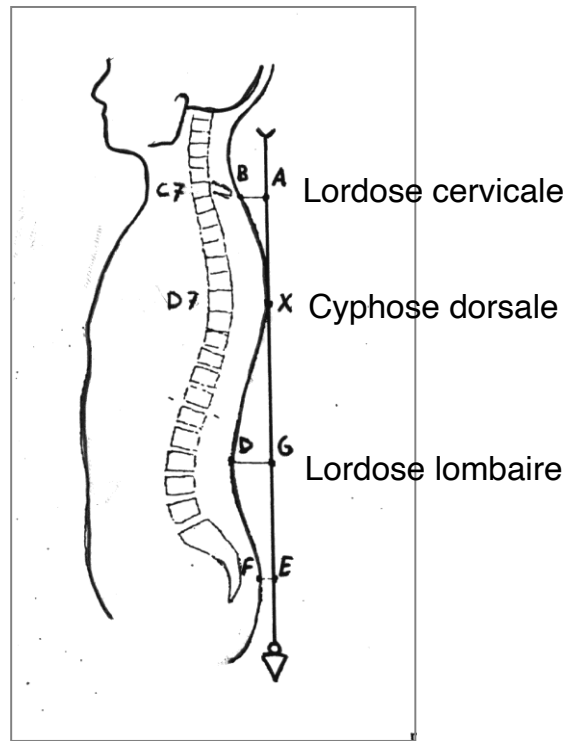
Dr Laudato

Examen clinique: Inspection des courbures

Cyphose et hypercyphose

- Limites du pathologique ?

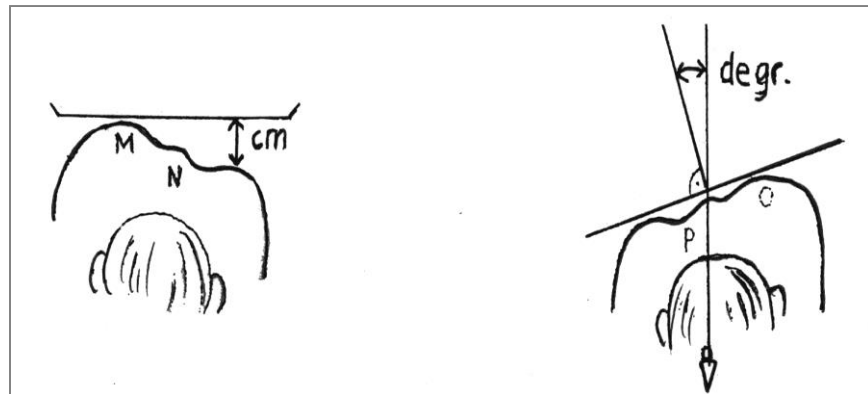
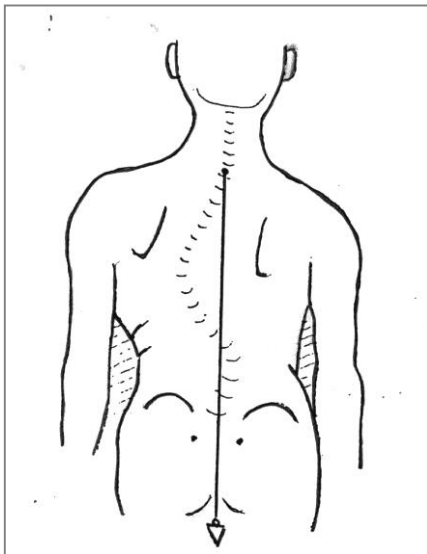
Flèches lombaire et cervicale : $AB + CD < 11\text{cm}$



Examen clinique: Inspection des courbures

Scoliose :

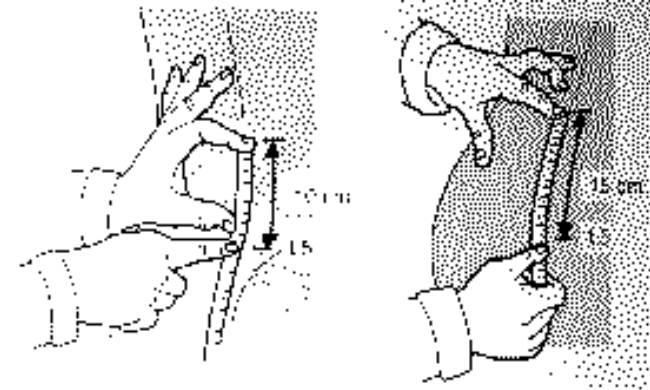
incurvation permanente du rachis de face caractérisée par une rotation vertébrale



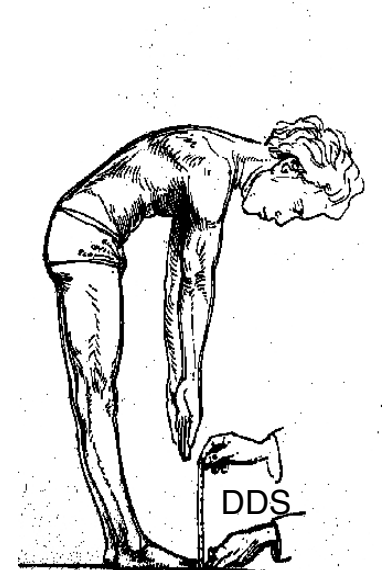
Gibbosité

Examen clinique: Mobilisation

- Flexion-Extension :
 - **Schober** lombaire 10 - 15 cm
 - OTT Dorsal 30 – (32-34) cm
 - Distance doigts sol: **DDS**



- Inflexion latérale
ex: Mobilité d'une scoliose
- Rotation
Jonction thoraco-lombaire
- Cervicale
Mobilité: Rotation D/G,
Flexion D/G,
Inclinaison D/G

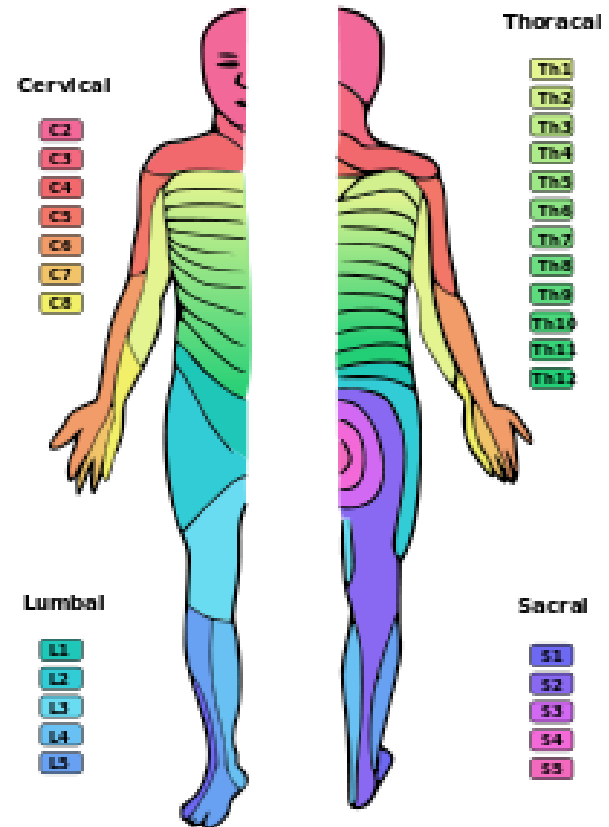


Examen clinique: Neurologique

examen de la sensibilité
(dermatomes)

examen de la force
réflexs

cf cours neurologie



Examen clinique: Neurologique

- Réflexes pathologiques (Babinski-Hoffman)
- Lasèque – Lasèque croisé
- Lasèque inversé
- Test de Bragard



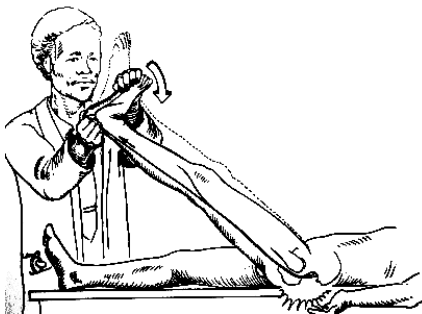
Babinski



Lasèque



Lasèque inversée



Test de Bragard

Examen clinique: Neurologique cervical

Hernie discale cervicale

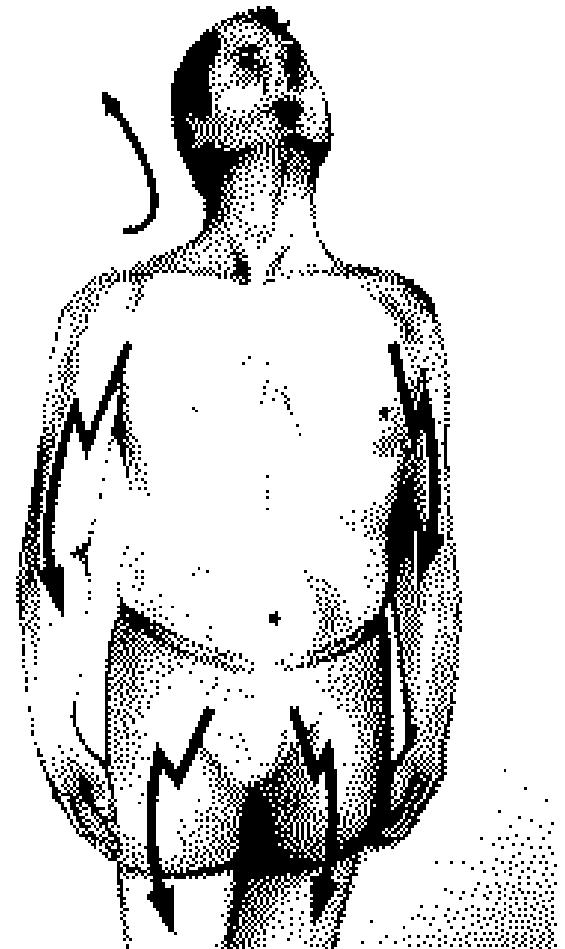
Signe de **Spurling**



Examen clinique: Neurologique cervical

Myélopathie cervicale :

- Clonus
- Signe de Lhermitte
- Signe de Hoffman



Examen clinique de la hanche

Dr Tissot

Inspection:

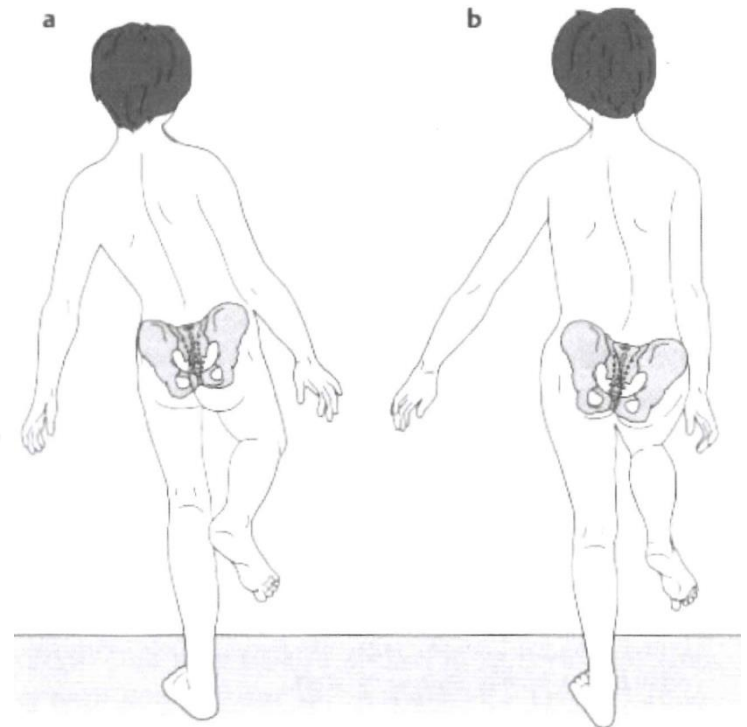
- De dos:
 - Equilibre bassin

**Signe de
Trendelenbourg**



Insuffisance m. Fessier

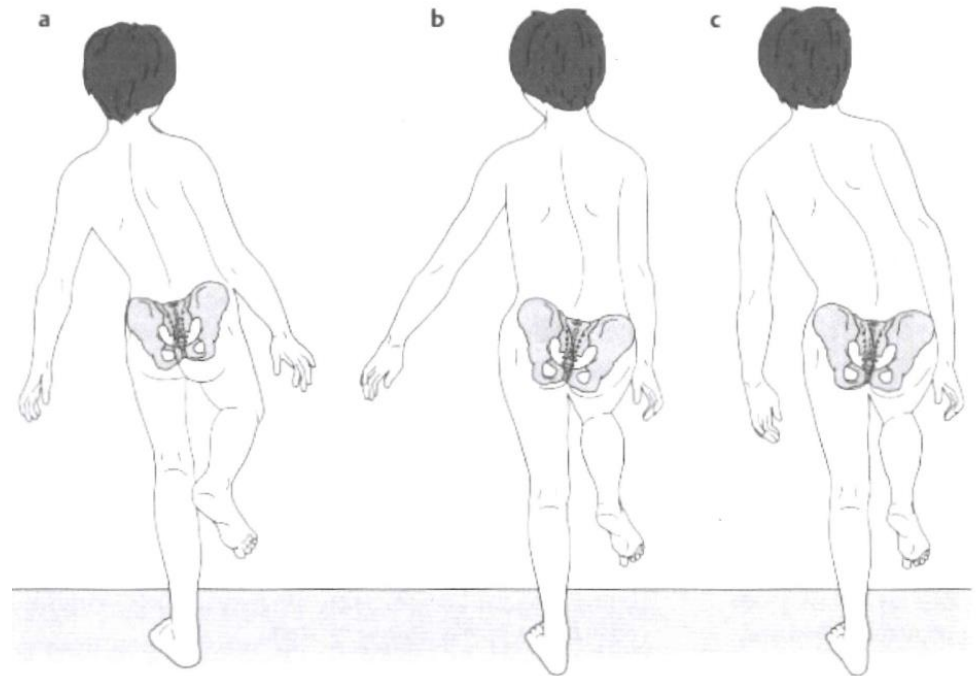
moyen



Marche:

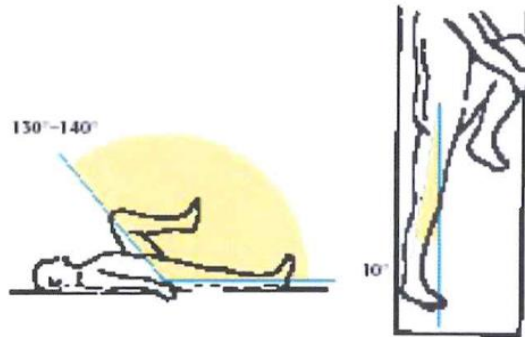
- Boiterie:
 - Antalgique (décharge)
 - Raccourcissement
 - Contracture
 - **Duchenne** (marche)

équivalent au signe de Trendelenbourg (statique)



Mobilités:

Flexion – Extension (norme $\cong 130^{\circ}$ - $140^{\circ}/0^{\circ}/10^{\circ}$)



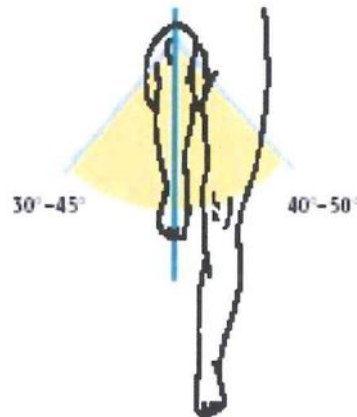
Flexion



Extension

Mobilités:

Rotation externe/ interne
(En flexion de 90° ; norme= 40° - 50° / 0° / 30° - 45°)



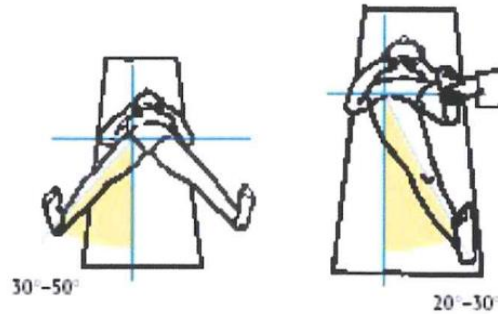
Rotation externe



Rotation interne

Mobilités:

Abduction – Adduction (norme $\cong 30^{\circ}$ - 50° / 0° / 20° - 30°)



Abduction

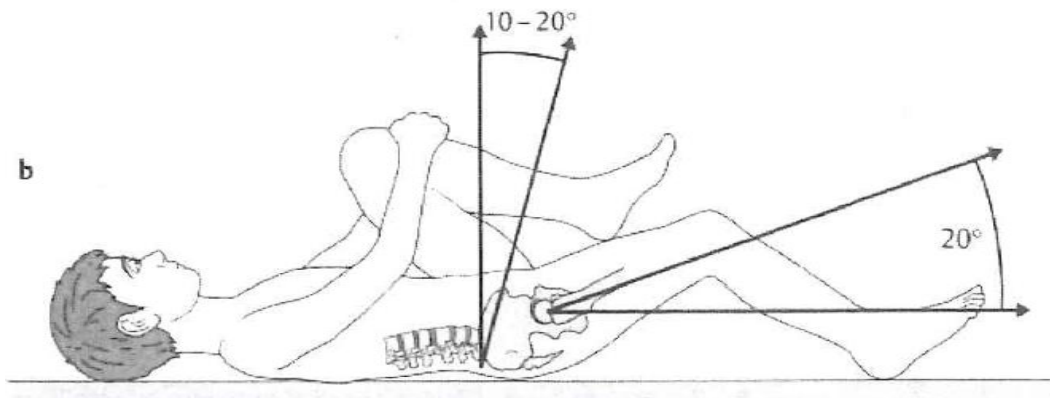
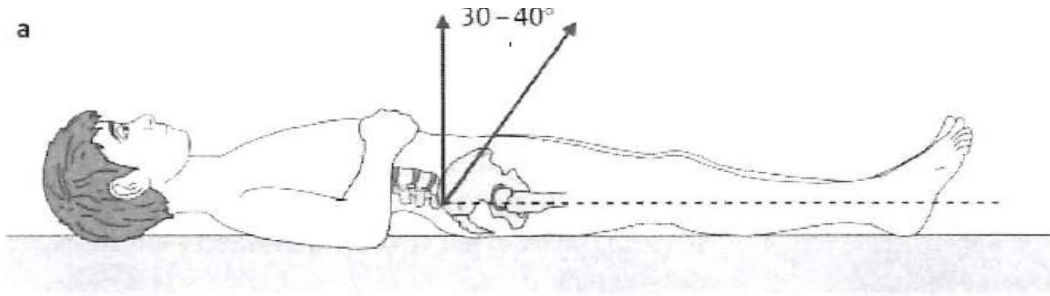


Adduction

Testing:

Recherche raccourcissement de l'ilio-psoas

- Manœuvre de **Thomas**:



**Flexum
De hanche?**

Testing:

- **Rolling:**

- Hanche en extension
- RI/RE passive

**Douleurs pli de
l'aîne**



Tr. dégénératifs

- **Piston:**

- Traction & compression hanche dans l'axe

**Douleurs
cuisse**

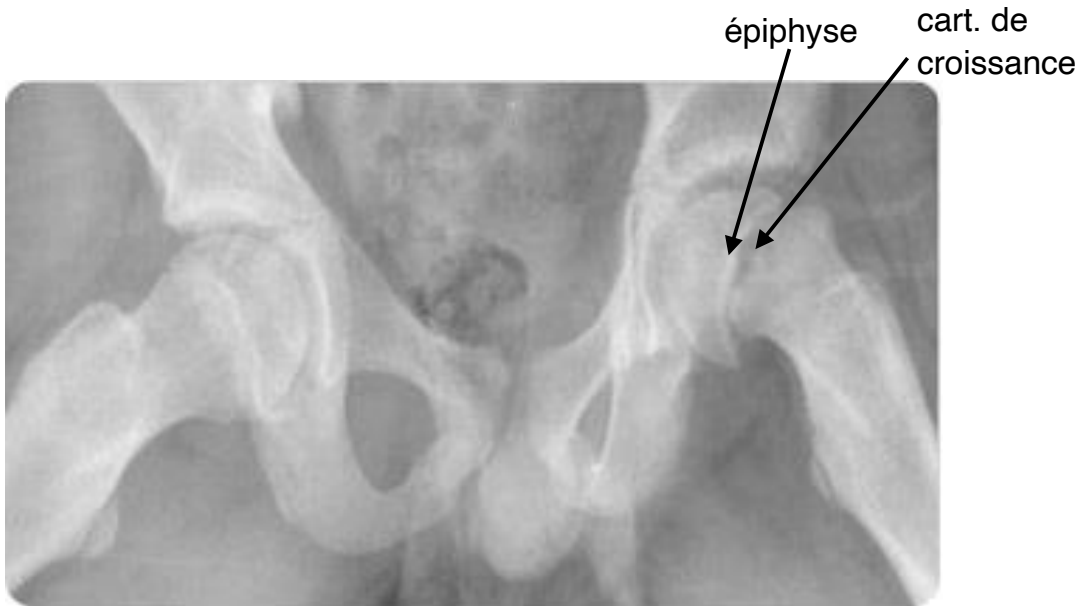


**Descellement tige
prothèse**

Testing:

Recherche: épiphysiolyse chez adolescent

- Signe de **Drehmann**:



**Rotation
externe
Automatique
En flexion**

Testing:

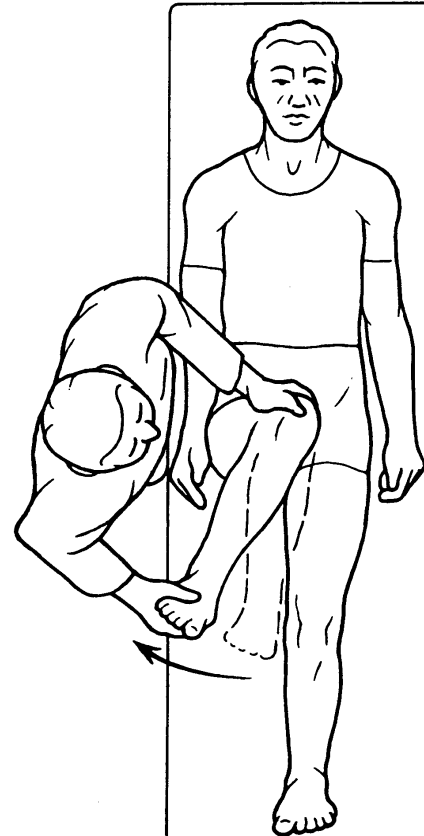
- **Impingement** test:

- Flex/RI/Add
FAdIR

CONFLIT

FEMORO-ACETABULAIRE

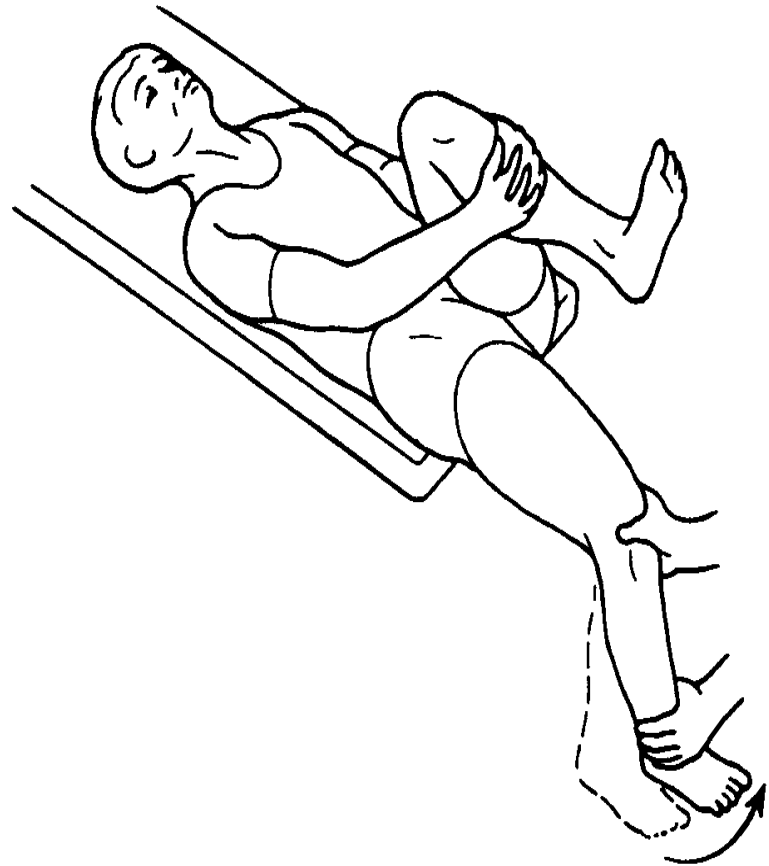
CFA
?



Testing:

- Apprehension test:
 - Ext/RE/Abd

CFA
?



Testing:

- Ressaut antérieur:
 - Flex/abd/RE -> Ext/add/RI
FABER

Psoas → **Eminence ilio-péctinée**

- Ressaut latéral:
 - Ext -> add/RI

Fascia Lata → **Grand Trochanter**

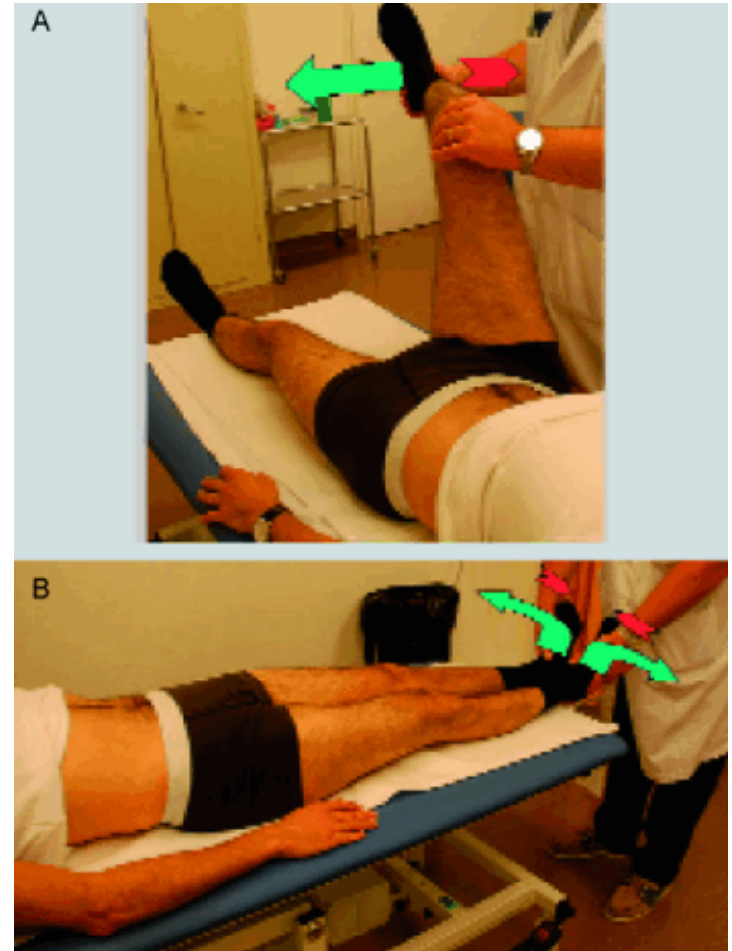
Testing:

- Test du Psoas:
 - Elevation de la jambe
 - +/- palpation
 - +/- contre résistance



Testing:

- Test du **pyramidal**:
 - RE contre Résistance



Examen clinique du genou

Dr Martin

Recherche d'un épanchement intra-articulaire

Signe du glaçon



Recherche d'une instabilité rotulienne



Recherche d'une instabilité sur lésion du LCA

Lésion LCA si trajet allongé avec arrêt mou



Tiroir antérieur



Pivot shift (pas important??)

Recherche d'une instabilité sur lésion du LLI et LLE

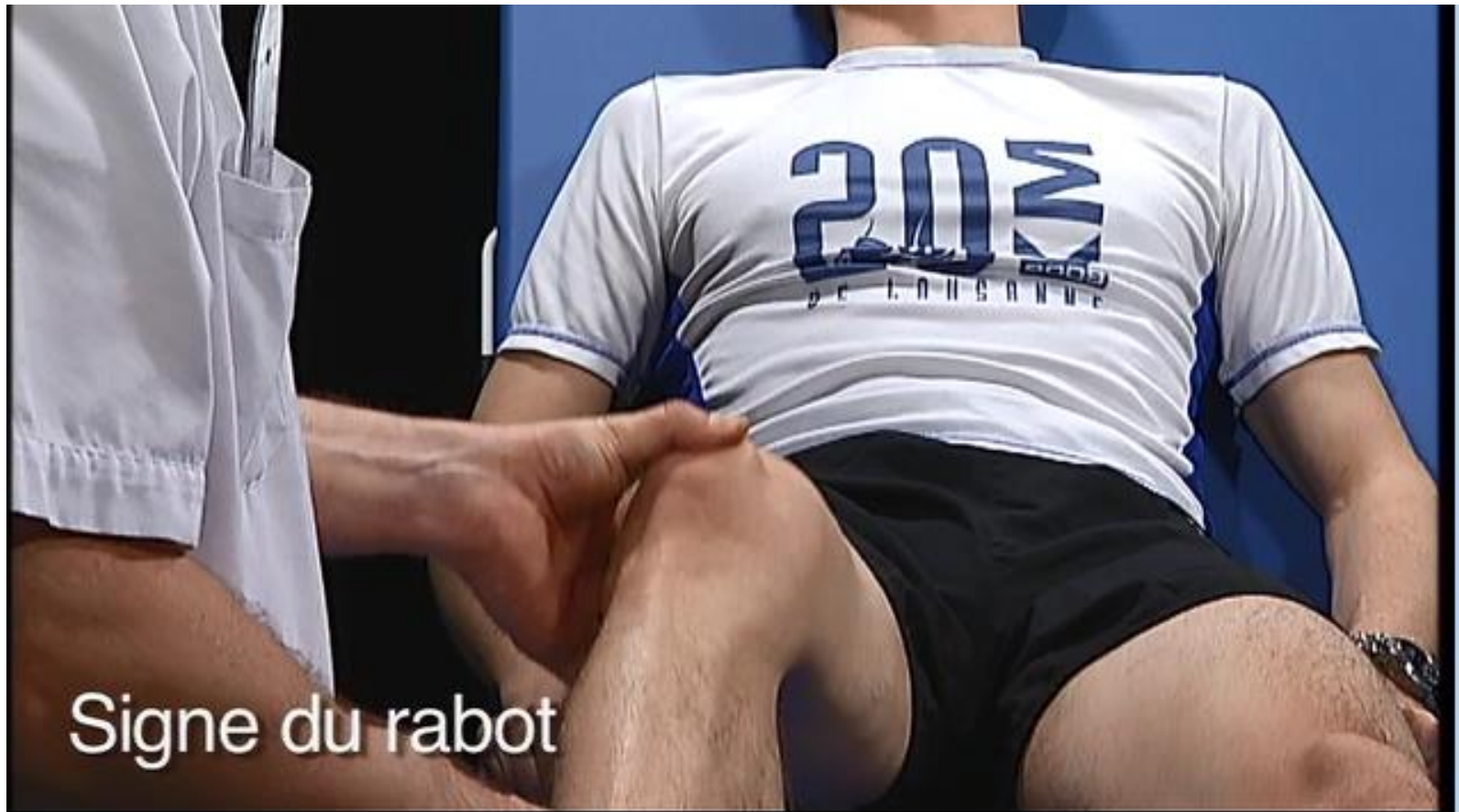


En extension:

Stress en valgus → lésion du LLI

Stress en varus → lésion du LLE





Pathologies fémoro-patellaires ??

Tester aussi:

Lésions méniscales: Grinding test: Décubitus ventrale

Lésion en anse de seau: Flessum irréductible

L'appareil extenseur (lésion du tendon du quadriceps ou du tendon rotulien)

Examen clinique du pied

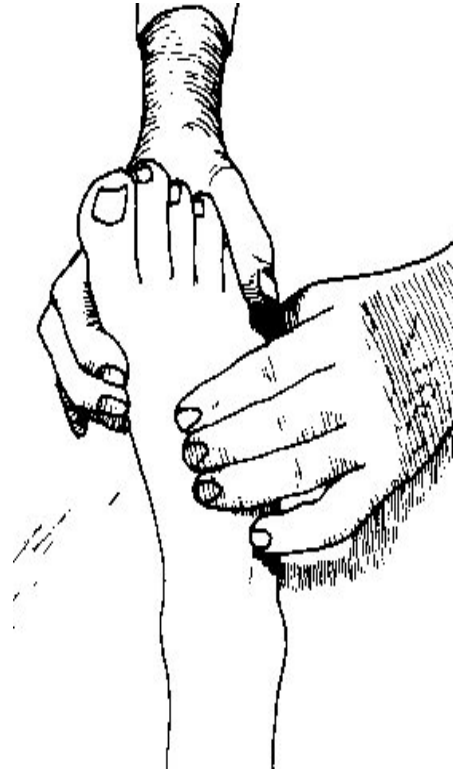
Dr Crevoisier

Pied

Examen vasculaire



Artère tibiale postérieure



Artère dos du pied

Hallux valgus

Inspection

Supraductus

Subductus

Conflit



Hyperkératose

Bursite



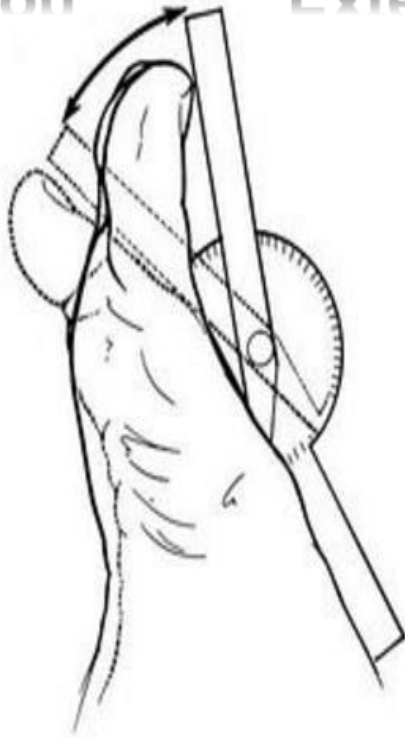
Griffes

Hallux valgus

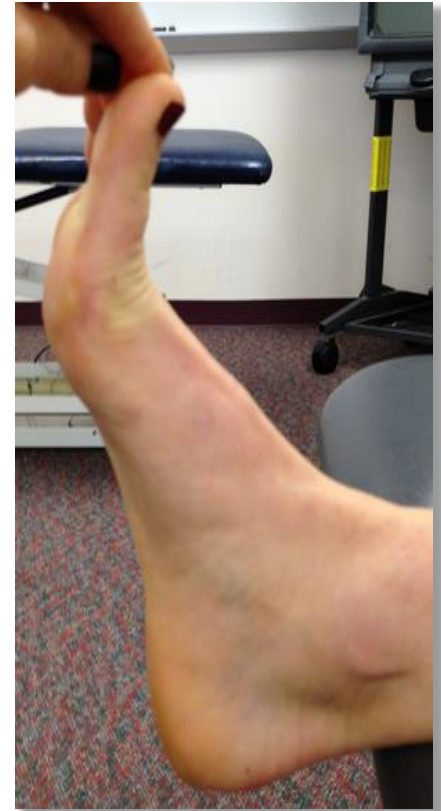
Mobilité 1^{ère} articulation méttarso-phalangienne (MTP1)

Flexion

Extension



Valeurs normales
F/E : 20-0-90



Hallux valgus

Neurostatus

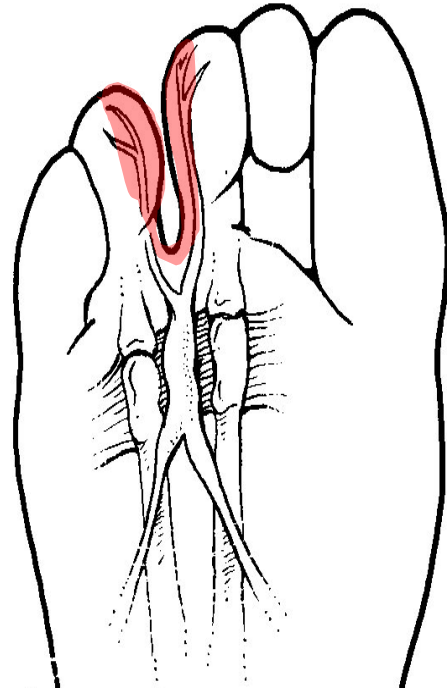
Neuropathie
péronier
superficiel



Nevralgie de Morton



Compression axiale
douloureuse
de l'espace intermétatarsien



Hypoesthésie
en livret

Arrière-pied

Inspection



Valgus
($>10^\circ$)



Neutre
($5-10^\circ$)



Varus
($\leq 0^\circ$)

Arrière-pied : pied creux

Réductibilité : Test de Coleman



En plaçant le bord externe du pied sur une planchette on libère l'appui excessif du premier rayon et le varus de l'arrière-pied se réduit.

Cette manœuvre indique une déformation flexible (≠ déformation fixée).

Arrière-pied

Fonction : lever en demi-pointes en monopodal (single heel rise)



Sous l'action
du muscle tibial
postérieur
et du triceps sural
l'arrière-pied
est verrouillé en varus



Le muscle tibial
postérieur est
Incompétent (par
lésion de son tendon)
et le triceps sural
tire l'arrière-pied
en valgus

Physiologique

Pathologique

Arche longitudinale

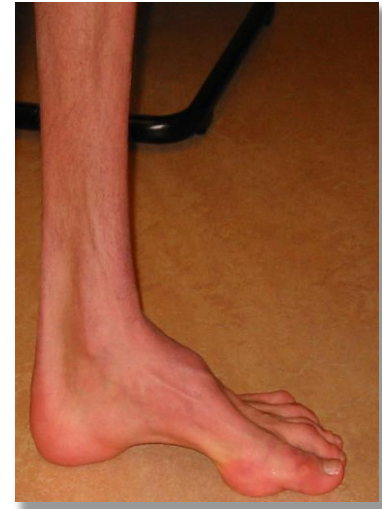
Inspection et empreinte



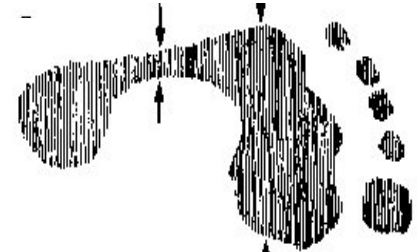
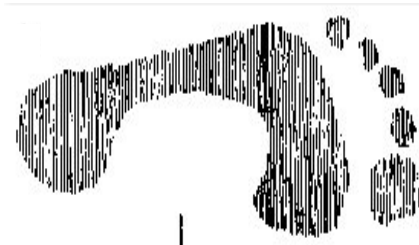
Planus



Neutre

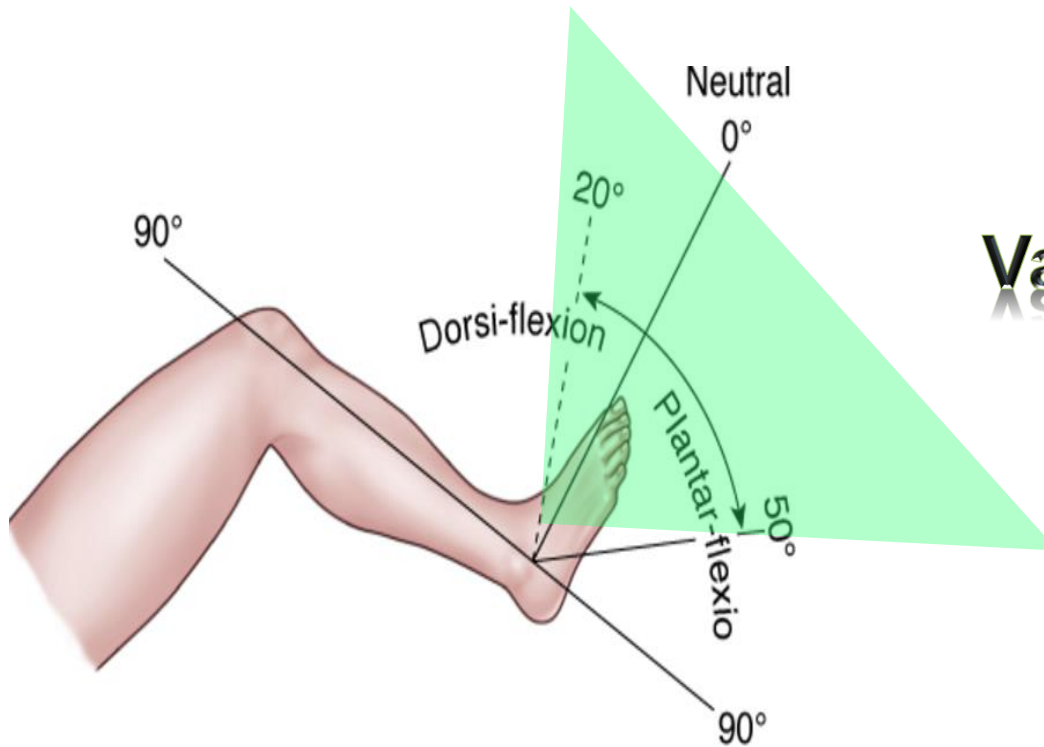


Cavus



Cheville

Mobilité: flexion-extension (F/E)



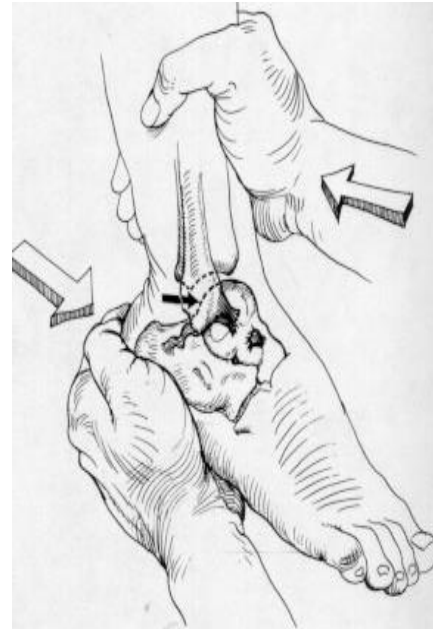
Valeurs normales
F/E : 50-0-20

Cheville

Recherche de laxité



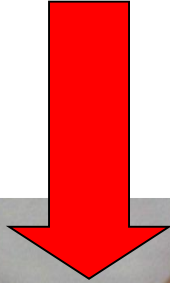
Contrainte en varus



Tiroir antérieur

Tendon d'Achille

Recherche de rupture



Solution de continuité



Test de Thompson

(le test est + si la compression du mollet ne provoque pas de flexion plantaire du pied)